

4

皮膚障害

手足症候群・ざ瘡様皮疹への対応

1 起こりやすい薬剤と症状パターン

手足症候群 (HFS)

カペシタビン・マルチキナーゼ阻害薬(レゴラフェニブ等)で頻度が高い。手掌・足底の紅斑・腫脹・疼痛、進行すると水疱・皮むけ

ざ瘡様皮疹

EGFR阻害薬(セツキシマブ・エルロチニブ等)に特徴的。顔面・体幹上部を中心としたニキビ様の発疹

爪囲炎

EGFR阻害薬・mTOR阻害薬等で。爪周囲の発赤・腫脹・疼痛

2 重症度の目安(CTCAE Grade)

Grade1

無症候性、日常生活に支障なし

Grade2

疼痛を伴う、身の回り以外の動作に制限

Grade3

高度、身の回りの動作に支障、水疱・潰瘍

3 患者さんに伝える観察ポイント・セルフケア



手のひら・足の裏の赤み、ピリピリ・ジンジンする感じ、皮むけ



保湿の習慣(こまめなクリーム塗布)、摩擦・締め付けの強い靴を避ける



顔や体幹の赤いブツブツ(ざ瘡様皮疹)がかゆみ・痛みを伴っていないか

4 薬剤師のチェックポイント

- ☐ Grade2以上は減量・休薬の目安になりうるため、疼痛の有無・日常生活への支障を具体的に聴取する
- ☐ 保湿剤・ステロイド外用薬の使用方法(部位・タイミング)を具体的に指導する
- ☐ 手足症候群は投与前からの保湿・角質ケアなど予防的スキンケアの説明が特に有効
- ☐ 強い発赤・熱感・膿など感染兆候がある場合は速やかな受診を勧める

皮膚症状はQOLへの影響が大きく、放置すると治療継続そのものを妨げる要因になる。「見た目の変化」を早期に共有してもらう関係づくりが大切。